

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II

Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής αποτελούν ειδικούς ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης II και έχουν ιδιότητες παρόμοιες με των α-MEA. Αντίθετα από τους α-MEA δεν αναστέλλουν την αποδόμηση της βραδυκινίνης και άλλων κινινών και για το λόγο αυτό δεν φαίνεται να προκαλούν τον μόνιμο ξηρό βήχα που συχνά επιπλέκει τη χρόνια χορήγηση των α-MEA. **Ως εκ τούτου, οι «Σαρτάνες» αποτελούν χρήσιμη εναλλακτική λύση για τους ασθενείς που πρέπει να διακόψουν τη λήψη κάποιου α-MEA εξαιτίας του επίμονου βήχα.**

Για τη δράση των ΑYA II στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις. Θεωρείται πάντως ότι μπορούν να δοθούν, αντί των α-MEA, εφόσον οι τελευταίοι δεν είναι ανεκτοί από τον ασθενή (βήχας, αγγειοοίδημα, κ.ά.) ή ακόμα και να συγχωρηθούν για πλήρη αναστολή της αγγειοτασίνης II.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	t _{max}	Χρόνος Ημιζωής
Losartan	<i>Cozaar/Lorotens</i>	50 – 100 mg	3-4 h	4-6 h
Eprosartan	<i>Teveten</i>	300 – 600 mg	2-6 h	5-7 h
Valsartan	<i>Diovan/Valsart</i>	80 – 320 mg	2-4 h	6-9 h
Candesartan	<i>Atacand/Fyronex</i>	8 – 32 mg	3-5 h	9-13 h
Azilsartan	<i>Edarbi</i>	40 – 80 mg	1,5-3 h	11 h
Irbesartan	<i>Aprovel/Lucidel</i>	75 – 300 mg	1-2 h	11-15 h
Olmesartan	<i>Olartan/Olmetec</i>	10 – 40 mg	1,5-3 h	12-15 h
Telmisartan	<i>Micardis/Pritor</i>	40 – 80 mg	1 h	24 h

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

Χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) με οιδήματα ανθεκτικά στη χρήση των διουρητικών της αγκύλης ή στην υδροχλωροθειαζίδη. Αυξάνουν τη Νατριούρηση και μειώνουν την Καλιούρηση (καλιοσυντηρηητικά διουρητικά). Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι η **Σπιρονολακτόνη** και η **Επλερενόνη**:

- tbs. **Aldactone** 25 mg, 100 mg, → 50-100 mg/24h. Μέγιστη δόση: 200 mg/24h
- tbs. **Inspira/Evadil/Inosamin** 25 mg, 50 mg, → έναρξη με δόση 25 mg/24h.

Για να χορηγηθούν οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης πρέπει η κρεατινίνη ορού να είναι σε επίπεδα Creat. < 2,5 mg/dl και τα επίπεδα Καλίου του ορού να είναι K⁺ < 5,0 mmol/l. Ο ασθενής αρχικά λαμβάνει 12,5 mg Σπιρονολακτόνης ή 25 mg Επλερενόνης και αν μετά από ένα μήνα το Κάλιο του ορού είναι σε επίπεδα K⁺ < 5,0 mmol/l κι εφόσον το απαιτεί η θεραπευτική αγωγή τότε η δόση διπλασιάζεται. Τα επίπεδα του καλίου (K⁺) στο αίμα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε όλους τους ασθενείς κατά την έναρξη της αγωγής, καθώς και περιοδικά από και πέρα, όπως και με οποιαδήποτε αλλαγή στην δοσολογία. Απαιτείται διαρκής και τακτική παρακολούθηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων στους ασθενείς που διατρέχουν σαφή κίνδυνο εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, όπως όσοι εμφανίζουν βεβαρημένη νεφρική και ηπατική λειτουργία ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Η Σπιρονολακτόνη ενισχύει τη δράση των θειαζιδικών διουρητικών, όσο και αυτών της αγκύλης. Προτιμάται κυρίως σε οιδήματα ή σε ασκίτη κιρρωτικών ασθενών και ενίοτε στα εμμένοντα οιδήματα της καρδιακής ανεπάρκειας που είναι ανθεκτικά σε άλλα διουρητικά.

Η Επλερενόνη (*Inspira, Inosamin, Evadil*) ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου της καρδιαγγειακής θνητότητας και της νοσηρότητας σε σταθερούς ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης LVEF ≤ 40%) και με κλινικές ενδείξεις ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας μετά από πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.